EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 67639
SERVICIO : UTI HSC
FECHA : 2023-07-18 13:59:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: JUAN PABLO CONTRERAS LARA			**RUN**	: 17.695.982-7
F.Nac	: 17-09-1990	**Edad**	: 32 AÑOS, 10 MESES	**Género**	: Masculino
Dirección	: GENERAL VENEGAS 451			**Comuna**	: SAN CARLOS
Previsión	: PARTICULAR	**Teléfono**	: 88605462		
Fecha Ingreso	: 2023-07-15	**Fecha Egreso**	: 2023-07-18 13:59:00	**Causal**	: SOLICITADA
Condición	: VIVO	**Destino**	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. K71.2-ENFERMEDAD TOXICA DEL HIGADO CON HEPATITIS AGUDA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Diagnósticos:
1. Insuficiencia hepática aguda, recuperada
- Obs. Sdme. Budd Chiari + Congestión
- Lesion Hipodensa 3.5CM en estudio
- Higado Congestivo
2. EPA resuelto
3. Reemplazo valvular aórtico reciente (válvula biológica 29/6/23)
- Endocarditis infecciosa válvula aórtica nativa por Streptococcus mitis
- Insuficiencia aórtica severa
4. VIH en TARV, reinicio terapia reciente, suspendida por elevacion transaminasas.
5. Antecedente meningitis por S. pneumoniae + endocarditis válvula aórtica (mayo 2020) tratadas.
6. Policonsumo de sustancias (THC, PBC) + Tabaquismo suspendido (mayo 2023)

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I50-INSUFICIENCIA CARDIACA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. D37.2-TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL INTESTINO (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

acude por disnea de 2 semanas, edema de MMII de 3 dias de evolucion, dolor abdominal
/Lab compatible con hepatitis aguda, GOT 1139, GPT 914, GGT 271, LDH 1862
Leucocitos 11000, Hb 11.3, plaquetas 423000, segmentados 71%, linfocitos 13
En profilaxis para pneumocistis con cotri forte./Familiar refiere que ha tenido trombosis previas, aparentemente embolías sépticas por endocarditis

Se inicia manejo con anticoagulacion , terapia depletiva por sospecha de higado congestivo.
Con buena respuesta clinica y de laboratorio.
COn transaminasas en normalizacion y sin signos congestivos.

se realiza tac trifasico de control que reporta signos de congestion hepatica , lesion hipodensa hepatica 3.6cm , ascitis leve. Se sugiere control con resonancia para caracterizacion.

Con indicacion de mantenerse hospitalizado para continuar estudio. Paciente solicita alta voluntaria , se le explican posibles diagnosticos desde infeccioso hasta malignidad pero igualmente decide retirarse y rechazar estudio hospitalizado.

Queda pendiente reinicio de TARV segun evaluacion en poli de vih. Pendiente igualmente resonancia y ecocardio.

solicito a paciente que al menos se quede en Hodom para continuar su manejo antibiotico a lo cual accede.

PLAN DE MANEJO:

Hemodinámico: Mantener terapia diurética y betabloqueo . Ecocardiograma de control. Control por cardiocx el martes 18/7/23 no se realiza por alta de paciente.
Ventilatorio: Sin conflicto actual
Infeccioso: completar 42 días de ceftriaxona (EBSA). Se suspendió TARV al ingreso UCI en contexto de falla hepática aguda, realizo IC poli VIH para seguimiento (carga viral y recto CD4 según indicación de este poli, último CD4 (12/06) 380 cel/ul) y evaluar reinicio/cambio TARV (previamente con 7. TenartaEM 200/300 mg 1 comp día VO y dolutegravir 50 mg al dia)

Gastro: función hepática estabilizada, solicito TC hepático trifásico. No descartable que falla hepática también pudiera estar en relación a congestión o farmacologica por TARV. Solicito JAK2 para descartar mieloproliferativo a sugerencia de gastroenterólogo. Se descarta trombosis por lo que se suspende anticoagulacion. Lesion Hipodensa 3.6 cm que se sugiere estudio con resonancia.

Proporcionalidad terapéutica: manejo activo

INDICACIONES AL ALTA

1. reposo relativo
2. regimen hiposodico.
3. omeprazol 20mg al dia vo
4. ceftriaxona 2g ev al dia (19/42 dosis)
5. Cotrimoxazol forte 1 al dia
6. Furosemida 40mg al dia vo
7. Espironolactona 25mg al dia
8. Propanolol 10mg cada 12 horas.
9. Pregabalina 75mg en la noche
10. ElcalD 1 al dia
11.
12. Control Poli Cardiocirugia , reagendar hora. -- tramitar
13. Control Poli VIH para control y reevaluar reinicio de TARV -- tramitado
14. Pendiente Jak2
15.
16. Se solicita ecocardio y resonancia abdomen cc para evaluar congestion y lesion hipodensa.

Jorge Andres Villa Flores
MEDICO TRATANTE
16178692-N

JEFE SERVICIO

Paciente o Familiar Responsable